

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

# Желудочно-кишечные кровотечения

Распознавание, оценка кровопотери и дифференциальный  
диагноз на догоспитальном этапе

---

Верхние и нижние источники, клинически скрытое кровотечение, оценка объёма  
кровопотери.

Состояния, имитирующие желудочно-кишечное кровотечение, и состояния, под которыми  
оно протекает скрыто.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

## Клинический случай

---

Вызов в 09:50 в рабочее общежитие, повод — «плохо, головокружение». Мужчина 41 года, работает на производстве, живёт в общежитии.

Три дня употреблял алкоголь, последний приём вчера вечером. Сегодня утром не смог выйти на смену: слабость, головокружение при попытке встать, тошнота без рвоты. Сам оценивает состояние как «обычное похмелье, только сильнее». Последнюю неделю из-за головной боли ежедневно принимал обезболивающее в таблетках — какое именно, назвать не может, «которое в аптеке дали, две-три в день». Рвоты кровью не было. На вопрос о стуле отвечает, что стул обычный, был вчера.

Объективно: сознание ясное, ориентирован. Кожа бледная с сероватым оттенком, прохладная, ладони влажные. При выполнении глюкометрии кровь из пальца поступает плохо, потребовался повторный прокол. АД **130/80 мм рт. ст. лёжа**; при переходе в положение сидя — **100/70 мм рт. ст.** с усилением головокружения и потемнением в глазах. ЧСС 100 в минуту, ЧД 18, SpO<sub>2</sub> 98 %, температура 36,4 °С. Живот мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии, симптомов раздражения перитонеума нет, перистальтика выслушивается. Глюкоза крови 5,8 ммоль/л. ЭКГ: синусовый ритм, тахикардия, без острых изменений. Пациент настаивает, что «отлежится», от поездки в стационар изначально отказывается.

Разбор случая приведён в конце материала.

## Вопросы для размышления

---

Ответы — в конце материала.

1. Почему нормальное артериальное давление в положении лёжа не исключает значимой кровопотери?
2. О чём говорят бледность с сероватым оттенком, прохладная кожа и плохое поступление крови из пальца?
3. Какое обязательное исследование остаётся невыполненным, если ограничиться словами пациента о нормальном стуле?
4. Почему алкоголь в анамнезе — самое опасное из возможных объяснений этой картины?
5. Что из принимаемых пациентом препаратов создаёт источник кровотечения и почему обезболивание на вызове ограничено?
6. Какой объём помощи выполняется до эвакуации и почему транспортировка идёт на носилках при сохранном сознании и «нормальном» давлении?

## Общие положения

---

Желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК) относится к числу состояний, при которых объём кровопотери на момент осмотра, как правило, недоступен прямой оценке: кровь депонируется в просвете желудочно-кишечного тракта, а её внешние проявления запаздывают по отношению к гемодинамическим. В части случаев кровотечение манифестирует не гематемезисом или меленой, а изолированными признаками гиповолемии — слабостью, головокружением, ортостатической гипотензией, синкопальным состоянием.

Летальность при ЖКК определяется преимущественно двумя обстоятельствами: недооценкой объёма кровопотери при формально сохранных показателях гемодинамики и поздним распознаванием кровотечения при отсутствии явных внешних проявлений.

Материал включает:

- терминологию и клинические проявления кровотечения в зависимости от уровня источника;
- методы оценки объёма кровопотери и их ограничения;
- дифференциальный диагноз источников кровотечения;
- состояния, имитирующие ЖКК, и состояния, при которых оно остаётся нераспознанным;
- догоспитальную тактику и сведения о расхождениях между действующими протоколами и данными международных исследований.

## Терминология и клинические проявления

| Проявление                             | Характеристика                                                                                                   | Уровень источника                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Гематемезис</b>                     | Рвота алой кровью, часто со сгустками                                                                            | Верхний отдел; активное кровотечение                                            |
| <b>Рвота «кофейной гущей»</b>          | Тёмно-коричневое зернистое содержимое: гемоглобин, изменённый хлористоводородной кислотой до гематина            | Верхний отдел; кровотечение состоявшееся или невысокой интенсивности            |
| <b>Мелена</b>                          | Чёрный дегтеобразный неоформленный стул со специфическим запахом; результат бактериальной деградации гемоглобина | Верхний отдел, реже тонкая кишка                                                |
| <b>Гематокезия</b>                     | Выделение алой или тёмной крови из прямой кишки                                                                  | Нижний отдел; при массивном кровотечении — верхний отдел с ускоренным транзитом |
| <b>Клинически скрытое кровотечение</b> | Внешние проявления отсутствуют либо не отмечены пациентом; клиника представлена признаками анемии и гиповолемии  | Любой уровень                                                                   |

Количественные ориентиры, определяющие клиническую картину:

- для появления мелены достаточно 50–100 мл крови, поступившей в верхние отделы; для формирования чёрного стула требуется время транзита, в среднем от 8 до 14 часов, в связи с чем при остром кровотечении мелена на момент осмотра может отсутствовать;
- мелена сохраняется в течение нескольких суток после остановки кровотечения и сама по себе не свидетельствует о его продолжении;
- гематокезия при верхнем источнике указывает на объём кровопотери, как правило, превышающий 1000 мл, и сопровождается нарушениями гемодинамики.



Внешние проявления желудочно-кишечного кровотечения: мелена — чёрный дегтеобразный неоформленный стул; гематемезис — рвота алой кровью; гематохезия — выделение крови из прямой кишки.

## Топическая диагностика: верхний и нижний уровень

Разделение проводится по связке Трейца (дуоденоюнальный переход).

| Признак                         | Верхнее ЖКК                                       | Нижнее ЖКК                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Частота                         | 70–80 % случаев                                   | 20–30 % случаев                                                     |
| Основные проявления             | Гематемезис, «кофейная гуща», мелена              | Гематохезия, тёмная кровь с калом                                   |
| Болевой синдром                 | Эпигастральная боль, анамнез диспепсии            | Часто отсутствует; при ишемическом колите и ВЗК — боль предшествует |
| Соотношение мочевины/креатинин  | Повышено (всасывание белков крови в тонкой кишке) | Не изменено                                                         |
| Аспират желудочного содержимого | Может содержать кровь                             | Не содержит крови                                                   |

Отсутствие крови в желудочном содержимом не исключает верхнего источника: при кровотечении из постбульбарных отделов дуоденального отдела кровь может не поступать в желудок.



Расположение источников кровотечения относительно связки Трейца и соответствующие им клинические проявления: выше связки — гематемезис и мелена, ниже — мелена (тонкая кишка) и гематохезия. АВМ — артериовенозная мальформация, ВРВП — варикозно расширенные вены пищевода, ЯБ — язвенная болезнь.

Примечание к схеме: в первые часы кровотечения концентрация гемоглобина может оставаться нормальной, поскольку эритроциты и плазма теряются пропорционально, а гемодилюция развивается позднее; нормальный уровень гемоглобина не отражает объема кровопотери.

## Оценка объема кровопотери

### Шоковый индекс Алговера

Отношение частоты сердечных сокращений к систолическому артериальному давлению.

| Индекс  | Ориентировочный дефицит ОЦК | Клиническая трактовка            |
|---------|-----------------------------|----------------------------------|
| 0,5–0,7 | Отсутствует                 | Норма                            |
| ~1,0    | 20–30 %                     | Шок I степени (компенсированный) |
| ~1,5    | 30–50 %                     | Шок II степени                   |
| ≥ 2,0   | ≥ 50 %                      | Шок III степени                  |

### Ограничения гемодинамической оценки

Нормальные показатели артериального давления не исключают значимой кровопотери. Основные причины несоответствия между объемом кровопотери и данными измерений:

- **Компенсаторная вазоконстрикция.** У пациентов молодого и среднего возраста артериальное давление удерживается за счёт периферического сопротивления и тахикардии вплоть до потери 30–40 % ОЦК; снижение давления соответствует срыву компенсации, а не началу кровотечения.
- **Артериальная гипертензия в анамнезе.** Давление 120/80 мм рт. ст. у пациента с привычными значениями 180/100 мм рт. ст. представляет собой относительную гипотензию.

- **Медикаментозная модификация ответа.**  $\beta$ -адреноблокаторы, ивабрадин, а также имплантированный электрокардиостимулятор препятствуют развитию компенсаторной тахикардии.
- **Возраст.** У пожилых компенсаторные возможности снижены, у пациентов с сердечной недостаточностью тахикардия может быть исходной.

### Ортостатическая проба

Измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений в положении лёжа и через 1–3 минуты после перехода в положение сидя или стоя. Значимым считается снижение систолического давления на 20 мм рт. ст. и более, диастолического — на 10 мм рт. ст. и более либо прирост частоты сердечных сокращений на 30 в минуту и более.

Проба позволяет выявить дефицит объёма при нормальных показателях в горизонтальном положении. Ортостатическая гипотензия, сопровождающаяся компенсаторной тахикардией, свидетельствует о гиповолемии; ортостатическая гипотензия без прироста частоты сердечных сокращений более характерна для автономной недостаточности и медикаментозного генеза. Проба не выполняется при исходной гипотензии, нарушении сознания и признаках шока.

## Клинически скрытое кровотечение

Ситуация, при которой кровотечение не сопровождается замеченными пациентом внешними проявлениями. Наиболее характерна для медленного кровотечения из хронической язвы, эрозивных поражений на фоне приёма НПВС, ангиодисплазий и опухолей.

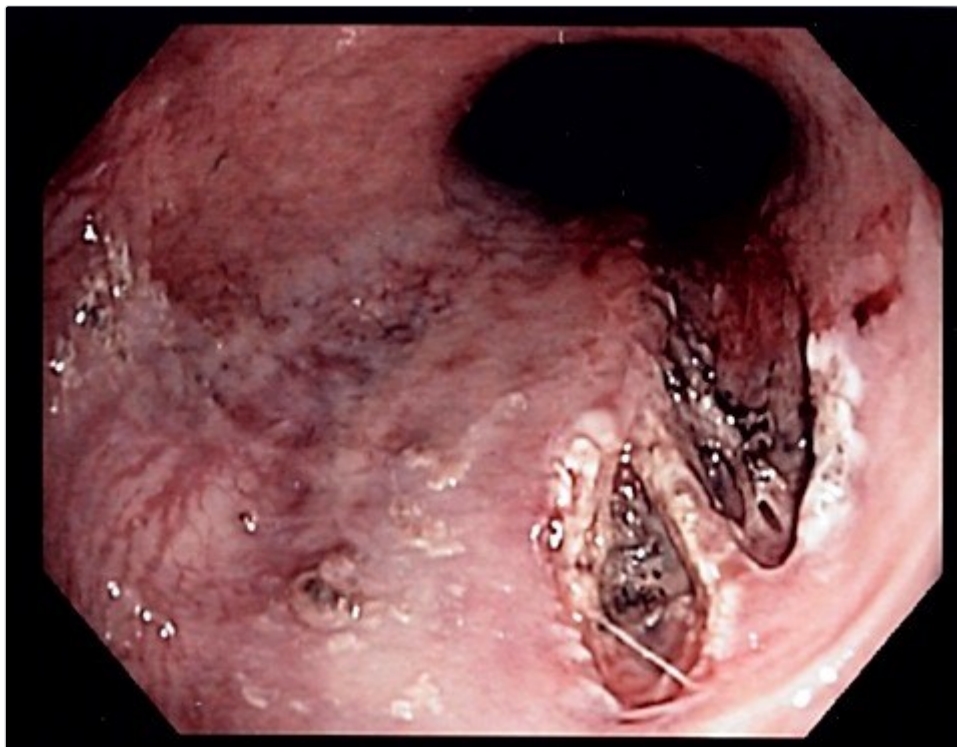
Клинические признаки, позволяющие заподозрить кровотечение при отсутствии гематемезиса и указаний на изменение стула:

- бледность кожи и слизистых, в том числе конъюнктив;
- слабость, снижение толерантности к нагрузке, головокружение при перемене положения тела, синкопальные состояния;
- тахикардия и ортостатическая гипотензия при нормальном давлении в покое;
- признаки периферической вазоконстрикции: холодные кожные покровы, замедленное капиллярное наполнение, акроцианоз;
- впервые возникшая или усилившаяся стенокардия, изменения на ЭКГ ишемического характера как следствие анемической гипоксии.

Пальцевое ректальное исследование с осмотром содержимого на перчатке позволяет выявить мелену либо следы крови и относится к обязательным элементам осмотра при подозрении на кровотечение, в том числе при отсутствии жалоб на изменение стула. Указание пациента на нормальный стул не заменяет исследования: изменение цвета кала нередко не замечается, а при отсутствии дефекации в течение предшествующих часов кровь может находиться в проксимальных отделах.

## Дифференциальный диагноз источников

| Верхние отделы                                         |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Источник                                               | Характерные особенности                                                                                                                                                                  |
| <b>Язвенная болезнь желудка и ДПК</b>                  | Наиболее частая причина (около 40 %). Анамнез диспепсии, эпигастральная боль, связь с приёмом НПВС, инфекция <i>H. pylori</i>                                                            |
| <b>Эрозивно-язвенные поражения</b> (гастрит, дуоденит) | Приём НПВС, ацетилсалициловой кислоты, глюкокортикоидов, алкоголя; стрессовые поражения при критических состояниях. Кровотечение чаще диффузное, умеренной интенсивности                 |
| <b>Варикозно расширенные вены пищевода и желудка</b>   | Портальная гипертензия при циррозе. Кровотечение массивное, часто алой кровью; сочетается с коагулопатией и тромбоцитопенией, что определяет тяжесть                                     |
| <b>Синдром Мэллори-Вейсса</b>                          | Продольный разрыв слизистой кардиоэзофагеальной зоны после многократной рвоты или интенсивного кашля. Типична последовательность: рвота желудочным содержимым, затем рвота с алой кровью |
| <b>Опухоли желудка и пищевода</b>                      | Пожилой возраст, потеря массы тела, анорексия, длительная анемия; кровотечение чаще хроническое                                                                                          |
| <b>Поражение Дъелафуа</b>                              | Аномально крупная подслизистая артерия. Массивное кровотечение без предшествующих симптомов и без язвенного анамнеза                                                                     |
| <b>Аортоэнтеральная фистула</b>                        | Состояние после протезирования аорты. Характерно «сигнальное» умеренное кровотечение, за которым следует профузное                                                                       |



Синдром Мэллори-Вейсса: продольный разрыв слизистой в кардиоэзофагеальной зоне, дефект покрыт фибрином, в дне определяется фиксированный сгусток.

## Нижние отделы

| Источник                                      | Характерные особенности                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дивертикулёз</b>                           | Наиболее частая причина у пожилых.<br>Внезапная безболевая массивная гематохезия                                        |
| <b>Ангиодисплазии</b>                         | Пожилкой возраст, хроническая болезнь почек, аортальный стеноз. Кровотечение рецидивирующее, нередко скрытое            |
| <b>Колоректальный рак</b>                     | Хроническая анемия, изменение характера стула, потеря массы тела                                                        |
| <b>Воспалительные заболевания кишечника</b>   | Кровь со слизью, диарея, боль, системные проявления                                                                     |
| <b>Ишемический колит</b>                      | Пожилкой возраст, атеросклероз, фибрилляция предсердий, эпизод гипотензии; болевой синдром предшествует появлению крови |
| <b>Геморроидальные узлы, анальная трещина</b> | Алая кровь поверх кала, без нарушений гемодинамики. Диагноз правомерен только после исключения проксимальных источников |
| <b>Постполипэктомическое кровотечение</b>     | Развивается в срок до 2 недель после эндоскопического вмешательства                                                     |

## Факторы, значимые для оценки риска

Приём НПВС, ацетилсалициловой кислоты, антикоагулянтов и антиагрегантов; хроническое употребление алкоголя; цирроз печени и портальная гипертензия; предшествующие кровотечения и эндоскопические вмешательства; онкологические

заболевания; хроническая болезнь почек; возраст старше 60 лет; сопутствующая кардиальная патология.

Признаки портальной гипертензии и хронического поражения печени, выявляемые при осмотре: телеангиэктазии, пальмарная эритема, гинекомастия, увеличение живота за счёт асцита, расширение подкожных вен передней брюшной стенки, иктеричность, следы расчёсов.

## Состояния, имитирующие желудочно-кишечное кровотечение

### Изменение окраски рвотных масс и стула без кровотечения

| Состояние                                                                                     | Проявление                                        | Дифференциальный признак                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Препараты железа, висмута, активированный уголь                                               | Чёрный стул                                       | Стул оформленный, без характерного запаха мелены; проба на скрытую кровь отрицательна |
| Употребление свёклы, красящих напитков, рифампицин                                            | Красная окраска стула или мочи                    | Отсутствие анемии и гемодинамических нарушений                                        |
| Кровотечение из носоглотки, полости рта, после стоматологических вмешательств, тонзиллэктомии | Заглатывание крови с последующей рвотой и меленой | Выявление источника при осмотре ротоглотки и полости носа                             |
| Кровохарканье                                                                                 | Выделение алой пенистой крови                     | Связь с кашлем, а не с рвотой; лёгочный анамнез                                       |

### Состояния, воспроизводящие клинику гиповолемии без кровотечения

Бледность в сочетании с ортостатической гипотензией и тахикардией не является специфичным признаком кровопотери и требует дифференциальной диагностики.

| Механизм                               | Состояния                                                                                                                                       | Дифференциальные признаки                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дегидратация                           | Рвота, диарея, недостаточное поступление жидкости, гипертермия, употребление алкоголя (подавление секреции АДГ этанолом с последующим диурезом) | Анамнез потерь, сухость слизистых, отсутствие анемии, отрицательное ректальное исследование |
| Осмотический диурез                    | Декомпенсация сахарного диабета, гипергликемические состояния                                                                                   | Гипергликемия, полиурия, кетоз                                                              |
| Минералокортикоидная недостаточность   | Первичная надпочечниковая недостаточность                                                                                                       | Гиперпигментация, гипонатриемия, потребность в соли                                         |
| Медикаментозная вазодилатация          | α-адреноблокаторы, нитраты, диуретики, антигипертензивные препараты, трициклические антидепрессанты, нейролептики                               | Связь с приёмом препарата, отсутствие тахикардии при автономной блокаде                     |
| Автономная недостаточность             | Диабетическая нейропатия, паркинсонизм и мультисистемная атрофия, амилоидоз                                                                     | Ортостатическая гипотензия без компенсаторной тахикардии                                    |
| Снижение производительности сердца     | Нарушения ритма и проводимости, инфаркт миокарда, тромбоэмболия лёгочной артерии, тампонада, аортальный стеноз                                  | Данные ЭКГ, аускультативная картина, характер боли                                          |
| Вазодилатация при системном воспалении | Сепсис, анафилаксия                                                                                                                             | Лихорадка либо очаг инфекции; уртикарии, ангиоотёк                                          |

### Сочетание состояний

Наличие альтернативного объяснения гиповолемии не исключает кровотечения. Клинически значимо, что ряд факторов одновременно предрасполагает к дегидратации и к кровотечению: хроническое употребление алкоголя сопровождается как диуретическим эффектом этанола и рвотой, так и высокой вероятностью эрозивного гастрита, варикозного расширения вен пищевода, синдрома Мэллори–Вейсса, а также коагулопатии и тромбоцитопении при поражении печени. По этой причине выявление факторов дегидратации у такого пациента расширяет, а не сужает объём необходимого обследования; диагноз дегидратации устанавливается после исключения кровотечения.

### Состояния, под которыми кровотечение протекает нераспознанным

- **Гастралгическая форма острого коронарного синдрома** — эпигастральная боль, слабость, гипотензия; требует регистрации ЭКГ. Возможно и обратное соотношение: анемия вследствие кровотечения провоцирует ишемию миокарда.

- **Расслоение аорты и разрыв аневризмы брюшной аорты** — боль и гиповолемия без наружного кровотечения.
- **Разрыв при внематочной беременности** у женщин репродуктивного возраста.
- **Инттоксикация и алкогольное опьянение** — маскируют изменения сознания, обусловленные гипоперфузией.

## Догоспитальная тактика

Мероприятия при желудочно-кишечном кровотечении в соответствии с действующими алгоритмами оказания скорой медицинской помощи:

| Мероприятие                                                  | Объём                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Положение                                                    | Горизонтальное; транспортировка на носилках независимо от самочувствия пациента                |
| Венозный доступ                                              | Периферический катетер большого диаметра; при признаках шока — два доступа                     |
| Инфузионная терапия                                          | Натрия хлорид 0,9 % 500 мл внутривенно капельно; при шоке — по протоколу геморрагического шока |
| Гемостатическая терапия                                      | Транексамовая кислота 750 мг (15 мл) внутривенно                                               |
| При кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода (I85) | Дополнительно терлипессин 1 мг (1 мл) внутривенно                                              |
| Оксигенотерапия                                              | При $SpO_2 \leq 93\%$                                                                          |
| Инструментальный контроль                                    | ЭКГ (дифференциальная диагностика с ОКС, оценка ишемии на фоне анемии), глюкометрия            |
| Режим                                                        | Приём пищи и жидкости исключается                                                              |
| Тактика                                                      | Экстренная госпитализация в стационар с эндоскопической службой, с предварительным оповещением |

Дополнительные положения:

- согревание пациента: гипотермия усугубляет коагулопатию;
- при неостановленном кровотечении инфузионная терапия проводится в объёме, обеспечивающем приемлемую перфузию, без стремления к нормализации артериального давления: избыточная инфузия сопровождается гемодилюцией, повышением давления в зоне повреждения и возобновлением кровотечения;
- нестероидные противовоспалительные препараты (в том числе кеторолак, метамизол) при продолжающемся кровотечении не применяются в связи с антиагрегантным действием и риском усиления кровотечения, а также с риском повреждения почек в условиях гипоперфузии;
- установка назогастрального зонда на догоспитальном этапе действующими алгоритмами не предусмотрена.

## Расхождения между действующими протоколами и данными международных исследований

| Вопрос                          | Действующий протокол                                              | Международные данные                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Транексамовая кислота при ЖКК   | Транексамовая кислота 750 мг внутривенно предусмотрена алгоритмом | Исследование HALT-IT (2020; 12 009 пациентов) не выявило снижения летальности при ЖКК; отмечено увеличение частоты венозных тромбозов и судорожных приступов. Эффективность транексамовой кислоты доказана при травме (CRASH-2) и послеродовом кровотечении (WOMAN), но не при ЖКК |
| Целевые показатели гемодинамики | Инфузионная терапия кристаллоидами                                | Рестриктивная стратегия: при циррозе и варикозном кровотечении избыточное восполнение объема повышает портальное давление и риск рецидива (Villanueva, 2013)                                                                                                                       |
| Ингибиторы протонной помпы      | На догоспитальном этапе не предусмотрены                          | Догоспитальное введение не влияет на летальность и потребность в гемостазе; оправдано в стационаре до эндоскопии                                                                                                                                                                   |
| Терлипрессин                    | 1 мг внутривенно при варикозном кровотечении                      | Соответствует международным рекомендациям (вазоактивная терапия до эндоскопии); учитывается риск ишемических осложнений и гипонатриемии                                                                                                                                            |

## Признаки, определяющие экстренность

| Признак                                                              | Клиническая интерпретация                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Гематемезис алой кровью, гематохезия при верхнем источнике           | Массивное продолжающееся кровотечение                                     |
| Шоковый индекс $\geq 1,0$ ; систолическое давление $< 90$ мм рт. ст. | Кровопотеря 20–30 % ОЦК и более                                           |
| Ортостатическая гипотензия при нормальных показателях в покое        | Скрытый дефицит объёма                                                    |
| Признаки портальной гипертензии                                      | Вероятность варикозного источника, массивного кровотечения и коагулопатии |
| Приём антикоагулянтов, антиагрегантов                                | Кровотечение, плохо поддающееся спонтанному гемостазу                     |
| Нарушение сознания, тахипноэ, олигурия                               | Декомпенсация, органная гипоперфузия                                      |
| Ишемические изменения на ЭКГ                                         | Анемическая гипоксия миокарда                                             |

## Возвращение к клиническому случаю

**Диагноз бригады.** Клинически скрытое желудочно-кишечное кровотечение, вероятный источник — эрозивно-язвенное поражение верхних отделов на фоне ежедневного приёма нестероидного противовоспалительного препарата. Ни одного «внешнего» признака кровотечения в этом вызове нет: ни гематемезиса, ни указаний на мелену, ни болей, требующих внимания. Есть только перфузия — и она вся указывает в одну сторону.

**Давление 130/80 ничего не исключает.** У мужчины среднего возраста компенсаторная вазоконстрикция удерживает нормальные цифры при потере, достигающей до трети объёма циркулирующей крови; гипотензия — это не начало кровотечения, а срыв компенсации. Поэтому оценивается не давление в покое, а его поведение при перемене положения: падение с 130/80 до 100/70 с усилением головокружения — это ортостатическая гипотензия и прямое указание на скрытый дефицит объёма. Проба занимает минуту и в этом вызове является главным диагностическим действием.

**Кожа и палец.** Бледность с сероватым оттенком, прохладная кожа, влажные ладони и **плохое поступление крови из пальца при глюкометрии** — всё это одна и та же находка: периферическая вазоконстрикция. Организм централизует кровоток, выключая периферию, чтобы удержать давление. Технический эпизод с повторным проколом здесь не бытовая неудача, а клинический признак, который стоит фиксировать в карте.

**Слова о стуле не заменяют исследования.** Пальцевое ректальное исследование с осмотром содержимого на перчатке относится к обязательным элементам осмотра при подозрении на кровотечение, и утверждение пациента о нормальном стуле его не отменяет: изменение цвета кала нередко просто не замечается, а при отсутствии дефекации кровь может ещё находиться в проксимальных отделах. У этого пациента исследование выполняется независимо от его ответа — и одновременно закрывает вопрос о геморроидальном источнике.

**Алкоголь — самый опасный якорь.** Он объясняет слабость, тошноту, головокружение и бледность целиком, поэтому позволяет закрыть вызов, не задавая больше вопросов. Проблема в том, что тот же анамнез создаёт сразу три независимых источника

кровотечения: эрозивно-язвенное поражение, синдром Мэллори-Вейсса после рвоты и варикозно расширенные вены пищевода при портальной гипертензии. Наличие альтернативного объяснения гиповолемии — включая банальную дегидратацию после запоя — кровотечения не исключает; при алкогольном анамнезе оба состояния закономерно сочетаются.

**Препарат из аптеки.** Ежедневный приём нестероидного противовоспалительного средства «две-три в день» в течение недели — это и есть механизм: подавление синтеза простагландинов, потеря защиты слизистой, эрозии и язвы, нередко без болевого синдрома, особенно на фоне алкоголя. Отсюда же следует ограничение по обезболиванию на вызове: кеторолак и метамизол при продолжающемся кровотечении не применяются — антиагрегантное действие и риск повреждения почек в условиях гипоперфузии.

**Объём помощи.** Горизонтальное положение, периферический катетер большого диаметра, натрия хлорид 0,9 % 500 мл внутривенно капельно, транексамовая кислота 750 мг внутривенно, запрет приёма пищи и жидкости, согревание, ЭКГ и глюкометрия, кислород при  $SpO_2 \leq 93\%$ . Инфузия проводится до приемлемой перфузии, а не до нормализации цифр: избыточный объём даёт гемодилюцию и возобновление кровотечения. Транспортировка **на носилках** — независимо от того, что пациент ходит и считает себя способным «отлежаться»: вертикальное положение у человека с дефицитом объёма провоцирует синкопе, а ортостатическая проба уже показала, чем это закончится.

**Отказ от госпитализации.** Здесь он опаснее, чем выглядит: субъективное самочувствие при скрытом кровотечении улучшается сразу после того, как пациент лёг, и это создаёт ложное впечатление стабильности. Разговор строится не на уговорах, а на конкретике: показанные ему самому цифры давления в двух положениях, объяснение, что источник кровотечения не закрылся сам, и прямое перечисление того, что произойдёт в течение ночи. Отказ, если он всё же оформляется, фиксируется вместе с ортостатическими показателями и результатом ректального исследования — это и есть документ, объясняющий, почему следующая бригада приедет к пациенту с гипотензией.

**Маршрут.** Стационар с круглосуточной эндоскопической службой, с предварительным оповещением. В передаче звучат: ортостатические цифры, частота сердечных сокращений, результат ректального исследования, недельный приём нестероидного противовоспалительного препарата, алкогольный анамнез и введённая транексамовая кислота.

## Резюме

---

- Объём кровопотери при ЖКК на догоспитальном этапе оценивается по показателям перфузии, а не по количеству видимой крови.
- Нормальное артериальное давление не исключает потери 30–40 % ОЦК у пациента молодого и среднего возраста; гипотензия соответствует срыву компенсации.
- Ортостатическая проба выявляет дефицит объёма при нормальных показателях в покое; сохранённый прирост частоты сердечных сокращений указывает на гиповолемическую природу.
- Пальцевое ректальное исследование относится к обязательным элементам осмотра при подозрении на кровотечение и не заменяется анамнестическими сведениями о характере стула.
- Мелена свидетельствует о состоявшемся кровотечении, но не о его продолжении; её отсутствие не исключает острого кровотечения.

- Наличие альтернативной причины гиповолемии, включая дегидратацию, не исключает кровотечения; при алкогольном анамнезе оба состояния закономерно сочетаются.
- Транспортировка осуществляется на носилках независимо от субъективного самочувствия пациента.
- Нестероидные противовоспалительные препараты при продолжающемся кровотечении не применяются.

## Источники

---

- Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи (Департамент здравоохранения города Москвы, 2025), раздел «Хирургические заболевания»; Приказ ДЗМ № 535.
- HALT-IT Trial Collaborators. Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding. *Lancet*, 2020.
- Villanueva C. et al. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. *N Engl J Med*, 2013.
- Gralnek I. M. et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: ESGE Guideline, 2021.
- Oxford Handbook of Emergency Medicine — gastrointestinal bleeding, hypovolaemic shock.
- Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide — upper and lower gastrointestinal bleeding.
- Верткин А. Л. Скорая медицинская помощь: руководство для фельдшеров и врачей.

## Ответы на вопросы для размышления

---

1. У пациента молодого и среднего возраста компенсаторная вазоконстрикция удерживает нормальные цифры при потере до 30–40 % ОЦК. Гипотензия — срыв компенсации, а не начало кровотечения. Оценивается поведение давления при перемене положения: падение с 130/80 до 100/70 с головокружением — ортостатическая гипотензия и указание на скрытый дефицит объёма.
2. Это одна находка: периферическая вазоконстрикция. Организм централизует кровоток. Плохое поступление крови из пальца при глюкометрии — клинический признак, а не бытовая неудача.
3. Пальцевое ректальное исследование с осмотром содержимого на перчатке. Слова пациента о нормальном стуле его не заменяют: изменение цвета кала нередко не замечается, а при отсутствии дефекации кровь может ещё находиться в проксимальных отделах.
4. Алкоголь объясняет слабость, тошноту, головокружение и бледность целиком и позволяет закрыть вызов. Тот же анамнез создаёт три независимых источника кровотечения: эрозивно-язвенное поражение, синдром Мэллори-Вейсса и варикозно расширенные вены пищевода. Дегидратация после запоя кровотечения не исключает.
5. Ежедневный приём нестероидного противовоспалительного средства в течение недели подавляет синтез простагландинов и даёт эрозии и язвы, нередко без боли. Кеторолак и метамизол при продолжающемся кровотечении не применяются: антиагрегантное действие и риск повреждения почек в условиях гипоперфузии.
6. Горизонтальное положение, периферический катетер большого диаметра, натрия хлорид 0,9 % 500 мл внутривенно капельно, транексамовая кислота 750 мг внутривенно, запрет еды и питья, согревание, ЭКГ, глюкометрия, кислород при SpO<sub>2</sub> ≤ 93 %. Инфузия — до приемлемой перфузии, не до нормализации цифр. Транспортировка на носилках: вертикальное положение при дефиците объёма провоцирует синкопе.

## Источники иллюстраций

| Файл                                | Что изображено                                        | Источник и лицензия             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| melena_hematemesis_hematochezia.png | Внешние проявления: мелена, гематемезис, гематоchezия | рисунок автора, CC BY-NC-SA 4.0 |
| gi_bleeding_sources.png             | Источники кровотечения относительно связки Трейца     | рисунок автора, CC BY-NC-SA 4.0 |
| mallory_weiss.png                   | Синдром Мэллори-Вейсса, эндоскопическая схема         | рисунок автора, CC BY-NC-SA 4.0 |

## Выходные данные

**Материал:** «Желудочно-кишечные кровотечения». Версия 1.0 от 16 августа 2026.

**Серия:** «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

**Лицензия:** текст и оригинальные схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

**Оговорка.** Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

**О клиническом случае.** Случай рассказан от лица бригады и обезличен: нет имени, даты вызова, адреса, номера карты вызова и названия стационара, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны: такие вызовы происходят ежедневно.

**Нашли ошибку?** Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.